



奇美醫療財團法人奇美醫院
Chi Mei Medical Center

給藥作業指導書

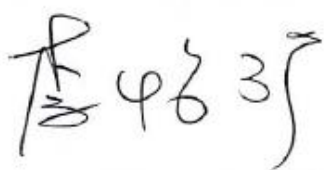
文件編號：總院-護理-作標-3-01030

版 次：04

制訂日期：2023-10-25

修訂日期：2025-02-27

擬案單位：護理部

訂修廢者	審核	核准
張素芳		

※管制文件不得擅自塗改及做記號並禁止影印。



奇美醫療財團法人奇美醫院
Chi Mei Medical Center

標準文件訂修廢履歷表

文件編號	總院-護理-作 標-3-01030	文件名稱	給藥作業指導書
使用部門	護理部		
版次	總頁數	文件修訂摘要	修訂日期
01	12	因應全院標準化文件格式整合，而重新制定。 1.修訂依據 4.2。 2.修訂原則 8.4.8.1、8.4.8.2。 3.更新內文圖三、圖四。	2023-10-25
02	12	1.刪除 8.2 給藥中作業內容要點說明 4-7.1 PCT 皮內注射 內容；新增 4-15.4、4-16、4-16.1、4-17、4-17.1。	2024-03-28
03	12	1.依據「住院病人自備藥管理程序書」更新，修訂 8.4.8.2。	2024-07-03
04	13	1.新增 8.2 給藥中要點說明 4-10.5。	2025-02-27



文件 編號	總院-護理-作標 -3-01030	文件 名稱	給藥作業指導書	頁次	1/13
				版次	04 版

1.目的：提供護理人員正確給藥之依據。

2.範圍：護理部所有單位。

3.權責單位：

3.1 文件制訂/修訂單位：作業標準委員會

3.2 文件審查單位/主管：作業標準委員會主席/督導

3.3 文件核定單位/主管：護理部/部長

3.4 文件發行單位：作業標準委員會

3.5 文件廢止單位：作業標準委員會

4.依據：

4.1 社團法人中華民國糖尿病衛教學會（2018）· 台灣胰島素注射指引 2018。

4.2 奇美醫療財團法人奇美醫院藥事委員會（2022）· 住院病人自備藥管理程序書。

http://media.chimei.org.tw/P/eval_plat/10/%E7%B8%BD%E9%99%A2-%E8%97%A5%E4%BA%8B%E5%A7%94-%E5%85%B1%E7%94%A8-2-00002%E8%87%AA%E5%82%99%E8%97%A5%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%A8%8B%E5%BA%8F%E6%9B%B8-01%E7%89%88_01.pdf

4.3 曹莉英、余怡珍、王玉女、徐秀琴、蔡麗紅、鄭幸宜、孫淑惠、張玉珠、王玉真、張怡雅、林秀純、陳迺茹、陳亭儒、高月梅、簡乃卉及劉碧霞（2018）· 新編基本護理學：藥理與技術（二版）· 新文京開發。

4.4 Smeulers, M., Verweij, L., Maaskant, J. M., de Boer, M., Krediet, C. T., Nieveen van Dijkum, E. J., Vermeulen, H. (2015). Quality Indicators for Safe Medication Preparation and Administration: A Systematic Review. *Public Library of Science one*, 10(4), e0122695. <http://doi.org/10.1371/journal.pone.0122695>



奇美醫療財團法人奇美醫院
Chi Mei Medical Center

文件 編號	總院-護理-作標 -3-01030	文件 名稱	給藥作業指導書	頁次	2/13
				版次	04 版

5.名詞解釋:無

6.執行地點: 護理部所有單位

7.物品準備: 無

8.作業內容:

8.1 給藥前:(流程圖)

步 驟	要 點 說 明
1.刷病人手圈條碼，系統自動跑出給藥系統畫面。	1-1 詢問病人當下服藥意願，再刷病人手圈條碼，並進行備藥。
1.1 無 Barcode 單位或系統異常情況下(例：系統當機)，依據病人辨識辦法執行病人辨識。	1.1-1 詢問病人當下服藥意願，再進行備藥。
2.以給藥系統備藥，並執行三讀七對。	2-1 檢視用物及設備之完整性。 2-2 大量點滴加藥或抽藥:當次抽藥後應立即給予施打病人身上，若當下因故無法於病床旁立即給予藥物時，將藥物抽至空針針筒內或點滴加藥，需標註病人姓名、病歷號、藥名、劑量、途徑，以手寫或列印標籤黏貼於點滴袋或針筒上。

8.2 給藥中:(流程圖)

步 驟	要 點 說 明
1.依據給藥「Time out」原則給藥。	1-1 口服藥「Time out」: 再次核對總顆數。
2.執行病人辨識。	1-2 針劑「Time out」: 再次核對劑量。 2-1 病人意識清楚時: 依病人手(腳)圈資料以反問法詢問病人，回答至少二項病人辨識資訊與手圈資料相符，同時核對電腦資料一致性。(如果無法核對電腦資料，應帶同電腦資料的書面資料核對: 如藥袋、病人標籤)。



奇美醫療財團法人奇美醫院
Chi Mei Medical Center

文件 編號	總院-護理-作標 -3-01030	文件 名稱	給藥作業指導書	頁次	3/13
				版次	04 版

步 驟	要 點 說 明
	2-2 無法回應或是意識不清時（兒童或已入睡之病人適用）： 2-2.1 有家屬者：應請家屬提供二項病人辨識資料，同時核對電腦資料一致性。（如果無法核對電腦資料，應帶同電腦資料的書面資料核對：如藥袋病人標籤）。 2-2.2 無家屬者： (1)有床頭卡：手圈、電腦與床頭卡進行病人身分核對。（如果無法核對電腦資料，應帶同電腦資料的書面資料核對：如藥袋、病人標籤）。 (2)無床頭卡：手圈、電腦與書面資料（例如：病人標籤、藥袋等）進行病人身分核對。 (3)急診如遇意識不清且無家屬可詢問之狀況，以手圈上資料配合病人照片等兩項資料加以辨識。（依品中病人辨識作業規範）。
3. 病人及家屬共同參與給藥活動。	3-1 衛教或反問病人或家屬所用藥物之作用、注意事項等。（不適用情境：病人認知障礙、意識不清、病危者、病人或家屬無法配合者）。
4.依各項給藥注意事項執行給藥。	4-1 眼滴藥：若需使用藥水與藥膏（油劑），則先使用藥水約 3-5 分鐘後，再使用藥膏（油劑）。 4-2 鼻滴藥：維持仰頭姿勢，以免藥物流出。 4-3 陰道栓劑：衛教病人張口呼吸減少腹壓以利塞入。 4-4 肛門栓劑： 4-4.1 衛教病人張口呼吸減少腹壓以利塞入。 4-4.2 若病人主訴有頭痛、冒汗，應立刻停止。 4-5 貼片製劑： 4-5.1 部位選擇：應貼在清潔乾燥、無毛髮的皮膚平面，並避開傷口和放射線照射部位。 4-5.2 貼片使用 12~24 小時後才達血中有效濃度，持續作用為 72 小時。 4-5.3 依醫囑更換貼片。



奇美醫療財團法人奇美醫院
Chi Mei Medical Center

文件 編號	總院-護理-作標 -3-01030	文件 名稱	給藥作業指導書	頁次	4/13
				版次	04 版

步 驟	要 點 說 明
	4-6 注射給藥： 4-6.1 由靜脈注射給藥者一律接上無針式延長線 (T connect)，盡量不使用針頭由橡皮塞直接推注藥物。 4-7 皮內注射： 4-7.1 PPD Test：注射後 48 小時及 72 小時由醫師來執行判讀，注射部位三角肌外側。 4-8 肌肉注射法（圖一）： 4-8.1 選擇注射部位：三角肌，臀肌或股外肌。 4-8.2 兩歲以下小孩通常選擇股四頭肌，嬰兒禁止注射臀部。 4-8.3 注射油性針劑，衛教病人勿按摩注射部位，並注意是否出現炎症反應。 4-8.4 精神科肌肉注射藥物有其獨特之限制，施打前應詳見仿單施打方式建議。 4-9 皮下注射（圖二）：每注射一次應輪換下個部位（如 A1-B1-C1...H1，A2-B2-C2...H2，以此類推）以免組織壞死。 4-10 穩定血糖藥物注射技術（包括胰島素、腸促胰激素及昇糖精注射技術）： 4-10.1 注射部位：上臂外側、腹部、大腿前側及外側、臀部（注意：腸促胰激素不能打在臀部）。 4-10.2 注射部位應輪換，以免組織壞死。 4-10.3 每次注射應距離上次注射部位大約 1 指寬，一個大部位可注射 8 次。 4-10.4 注射技術分為筆型胰島素、瓶裝胰島素、腸促胰激素，注射方式為皮下注射方式，昇糖精注射方式依醫囑執行（附件 10.6-10.11）。 4-10.5 若胰島素自冰箱冷藏取出，應置於室溫 5-10 分鐘再進行注射，避免造成不適。 4-11 直接靜脈注射：每次給藥前後以針筒推注生理食鹽



奇美醫療財團法人奇美醫院
Chi Mei Medical Center

文件 編號	總院-護理-作標 -3-01030	文件 名稱	給藥作業指導書	頁次	5/13
				版次	04 版

步 驟	要 點 說 明
	水，避免藥物彼此間不相容反應及藥物沉積造成阻塞，注入藥物時需隨時觀察病人有無不適之反應。 4-12 靜脈留置針注射法： 4-12.1 靜脈留置針及連續性靜脈輸液系統（IV set、bag）96 小時應更換，個案經評估注射部位有滲液，或紅、腫、熱、痛，應即刻拔除。 4-12.2 針孔處有血水、滲液時，需立即適當處理。 4-13 皮下留置針注射法： 4-13.1 選擇注射部位：手臂上臂、大腿外側、肩胛棘下方、腹部。 4-13.2 皮下留置針應每 7 天更換一次。 4-14 大量點滴及更換點滴： 4-14.1 不可將靜脈輸液放低於注射部位來確定是否通暢，以免回血凝固，增加栓塞的危險性。 4-14.2 使用 IV Pump 者，先測試幫浦功能正常，並依使用規範設定輸液速。 4-15 由靜脈給液加藥法： 4-15.1 若滴數小於 10ml/hr 使用 Bag 時，須先加藥再排氣，以確定藥物作用。 4-15.2 應使用新的注射針和針筒進入藥瓶抽取藥品，不可將針頭留置於藥瓶上重複抽取藥品，且病人使用過之注射針(筒)不可重複使用。 4-15.3 病人同時使用不同類型的藥物時，為避免藥物間產生交互作用，可備用足量的精密輸液 bag，並須標上專用之藥物名稱，以作區別。 4-15.4 使用精密輸液 bag 給藥，應於給藥後沖注生理食鹽水，確認藥物滴注完畢。 4-16 由全植入式靜脈導管(Port)給藥法 4-16.1 每次間歇性治療給藥前後以針筒推注 10ml 生理食鹽水，避免藥物彼此間不相容反應及藥物沉積造成阻塞，詳見「總院-護理-作標-3-01032



奇美醫療財團法人奇美醫院
Chi Mei Medical Center

文件 編號	總院-護理-作標 -3-01030	文件 名稱	給藥作業指導書	頁次	6/13
				版次	04 版

步 驟	要 點 說 明
	全植入式靜脈導管(Port)彎針注射技術指導書」。 4-17 由週邊植入式中心導管(PICC)給藥法 4-17.1 每次給藥後以 10ml 生理食鹽水沖洗管路，避免藥物彼此間不相容反應及藥物沉積造成阻塞，詳見「總院-護理-作標-3-01065 週邊植入式中心導管(PICC)護理術-成人指導書」。 4-18 全靜脈營養滴注給藥法： 4-18.1 TPN 溶液須由中央靜脈導管輸入。 4-18.2 TPN 配置後依醫囑冷藏 2~8°C 保存 72 小時，並依醫囑滴完；若加入 Lipofundin 製劑，則不可冷藏，室溫保存 24 小時。 4-18.3 TPN 及其輸液系統 (IV set) 在室溫下使用超過 24 小時請丟棄，以免細菌孳生。 4-18.4 每天應檢視注射部位，若發紅直徑 > 2 公分、腫脹痛、體溫變化、心悸、噁心、頭痛、疲憊時，應通知醫師處理。 4-18.5 Single Lumen Catheter 之 TPN 注射系統，絕不可輸血、抽血、注射其它藥物及測量 CVP 值；若為多腔導管，TPN 則需固定於單一導管輸注。 4-18.6 在實行 CVC 值測量時，勿將 TPN 接於 Distal 端，且測量時須暫將 TPN 溶液停止滴注。 4-19 麻醉管制藥物取藥步驟： 4-19.1 取藥前：主護依據「管制藥處方簽」於「麻藥藥品登記簿」寫上抽藥日期、時間、基本資料、醫囑醫師、醫囑劑量、取用支數，當班主管（或代理人）須同時確認主護書寫正確性。 4-19.2 取藥中：主護須依據「管制藥處方簽」自正確麻管藥盒取出正確麻管藥物，並抽取正確藥物劑量，當班主管（或代理人）需全程注視主護



奇美醫療財團法人奇美醫院
Chi Mei Medical Center

文件 編號	總院-護理-作標 -3-01030	文件 名稱	給藥作業指導書	頁次	7/13
				版次	04 版

步 驟	要 點 說 明
	抽藥正確性。 4-19.3 取藥後： (1) 當班主管（或代理人）及主護，須同時注視且口頭覆誦剩餘劑量並棄藥，空藥瓶需分不同藥物放入藥品收集盒。 (2) 主護於「麻藥藥品登記簿」寫上丟棄劑量、結餘支數，並且與當班主管（或代理人）同時簽名於執行者（主護）/核對者（當班主管），並且同時進行麻管藥物上鎖。 4-20 若給藥過程中斷（離開工作車），須重新執行給藥技術流程，依給藥前：步驟 1~2 及給藥中：步驟 1~4 重新進行給藥。

8.3 給藥後：

步 驟	要 點 說 明
1.病人確實服下藥物後，才可簽核。 2.觀察病人。 3.紀錄。	2-1 靜脈注射部位皮膚若有發紅、腫脹應立即拔除重新更換注射部位。 3-1 STAT、PRN 藥物給藥後需進行護囑系統之「給藥追蹤」，追蹤時間應以各藥物作用時間進行評估(圖三)。 3-2 因「暫停」、「檢查/手術」、「拒絕」未服藥者，應將原因書寫於「給藥系統」之「暫停說明/執行記錄」(圖四)。

8.4 原則：

8.4.1 依醫囑正確執行給藥。

8.4.2 給藥時需確實執行三讀七對（藥袋上之藥品名稱應清楚，可辨識）。

8.4.3 給藥前應了解藥物之作用、副作用，對於不熟悉之藥物可參閱



文件 編號	總院-護理-作標 -3-01030	文件 名稱	給藥作業指導書	頁次	8/13
				版次	04 版

藥袋、給藥系統內之藥典/仿單等。

8.4.4 臨時醫囑、必要時用藥及雙人核對藥物，須依藥物作用時間追蹤給藥反應（排除化療藥物，但須於「化學治療副作用評估」系統進行給藥後副作用評估）及記錄。如出現藥物不良反應需通知醫師。

8.4.5 高警訊性用藥詳見「高警訊藥物管理規範」。

8.4.6 給藥前後需洗手，注射藥物者需依無菌技術執行。

8.4.7 護理人員不得給予病人非正式醫囑或非藥師調劑之藥物。

8.4.8 住院病人自備藥（依據 113 年 1 月住院病人自備藥管理程序書）：

8.4.8.1 醫囑：醫師/專師針對病人之自備藥，先依照病人病情進行整體性評估；評估後，若需於住院期間繼續服用，則由醫師/專師開立「自備藥醫囑」，並記載使用藥物名稱、規格、服用劑量、頻次、用法與使用期限，自備藥不得開立「自備自服」醫囑；遇無法辨識或者有辨識疑慮之自備藥品，則重新開立本院藥品。若有用藥相關疑問時（如：重複用藥），可照會藥師協助。

8.4.8.2 給藥：病人之自備藥品，得經主治醫師同意後，由護理人員依「自備藥醫囑」記載之藥品名稱、劑量、頻次、給藥途徑按時給予病人，不得交由病人「自備自服」，排除需要時使用之外用藥膏、漱口水、氣喘吸入劑及「非處方」眼藥水。護理人員執行自備藥給藥時須確實由病人之自備藥取用，不可以院內發放之藥物替代。

8.4.9 所有藥物（含自備或自費藥）需經由護理人員排藥並給藥之藥物，若醫囑開立則會自行由系統帶入護囑系統-給藥記錄中。

8.4.10 初次給藥之藥物，須主動提供給病人該藥之資訊：藥物作用、副作用、注意事項。

8.5 注意事項：



文件 編號	總院-護理-作標 -3-01030	文件 名稱	給藥作業指導書	頁次	9/13
				版次	04 版

8.5.1 如果行動護理車因環境限制等因素無法進入病人單位時，應以貼有病人資料之標籤進行備藥及核對電腦上病人基本資料，至病人床旁時再與病人及手圈進行辨識。

8.5.2 給藥時需確實執行三讀七對。

8.5.2.1 第一讀：取對正確藥盒。

a. 單一劑量藥物（UD 藥）：讀床號。

b. 非單一劑量藥物：於藥品存放處，取出正確藥物。

8.5.2.2 第二讀：取藥時（拿對正確病人的藥袋及藥物，並執行病人姓名、病歷號、出生年月日資料擇兩項進行辨識）。

a. 六對：進行給藥護囑系統內容核對，依內容呈現順序，讀床號、姓名、病歷號（病人對）、藥名（藥名對）、劑量（劑量對）、途徑（途徑對）、預計給藥時間（時間對）及指示說明（理由對）。

8.5.2.3 第三讀：歸藥或丟棄藥物時。

a. 單一劑量藥物（UD 藥）：放回正確的藥盒。

b. 第七對：給藥確認（記錄對）。

8.5.2.4 給藥七對：以給藥系統備藥，並執行七對（7 Rights）：

a. 病人對：備藥時、給藥前需確認病人正確（核對二種以上基本資料）。

b. 藥名對：核對藥名及劑型正確。

c. 劑量對：口服藥需確認顆粒總數、需稀釋藥物應確認稀釋劑量正確、IV 滴藥物應確認流速正確。

d. 時間對：常規藥物於給藥時間點前後 30 分鐘給藥、STAT 醫囑於醫囑開立後 30 分鐘內給藥，如醫囑有開立給藥「時/地」，應於醫囑時/地執行。



奇美醫療財團法人奇美醫院
Chi Mei Medical Center

文件 編號	總院-護理-作標 -3-01030	文件 名稱	給藥作業指導書	頁次	10/13
				版次	04 版

e.途徑對：不熟悉的給藥途徑應確認後再執行。

f.理由對：確認是否符合該藥物醫囑指示說明之給藥條件。

g.記錄對：正確記錄給藥內容，依三讀備完藥時，需將藥物點選至「需給藥追蹤及此次給藥資料」，口服藥需確認病人已服下，其他藥物需確實給完藥後，再點選「給藥確認」。

8.5.3 病人請假外出，一律不可外帶藥物返家（除醫師醫囑開立），須於給藥常規時間後詢問醫師是否補給藥，並紀錄。

8.5.4 預充填（單劑型）疫苗建議不排氣即行注射，自行抽取疫苗之品項則依護理技術標準，先行排氣再行注射。（依據 2019.7.23 台南市政府衛生局，南市衛疾字第 108129055 號）

8.5.5 經綜整國際對執行肌肉或皮下注射疫苗之文獻與實務作法，疫苗接種前得採不反抽，以降低可能引起之疼痛。惟依基本護理標準技術，亦可先行反抽確認無回血再行注射。（依據 2019.7.23 台南市政府衛生局，南市衛疾字第 108129055 號）。

8.5.6 執行注射或給藥時需備好針頭回收盒，全面禁止針頭回套。



Figure 1 consists of two diagrams, (A) and (B), illustrating injection sites for the gluteal and quadriceps muscles.

Diagram (A) shows a posterior view of the right gluteal region. The gluteus medius, gluteus maximus, and gluteus minimus muscles are depicted. The greater sciatic foramen, greater sciatic nerve, and greater sciatic artery are labeled. The injection site is marked on the gluteus medius muscle.

Diagram (B) shows an anterior view of the right thigh. The quadriceps muscles (vastus medialis, vastus lateralis, vastus intermedius, and rectus femoris) are shown. The injection site is marked on the vastus medialis muscle.

The diagrams illustrate the front and back views of a human figure with numbered points for acupoint location. The front view (left) shows points A, B, C, D, E, F, I, J, and the back view (right) shows points A, B, G, H. Each point is associated with a 2x4 grid of numbers (1-8) indicating specific locations.

Front View (Left):

- Point A:** 1 2 3 4 / 5 6 7 8
- Point B:** 1 2 3 4 / 5 6 7 8
- Point C:** 1 2 3 4 / 5 6 7 8
- Point D:** 1 2 3 4 / 5 6 7 8
- Point E:** 2 1 / 4 3 / 6 5 / 8 7
- Point F:** 1 2 / 3 4 / 5 6 / 7 8
- Point I:** 1 2 3 4 / 5 6 7 8
- Point J:** 1 2 3 4 / 5 6 7 8

Back View (Right):

- Point A:** 2 1 / 4 3 / 6 5 / 8 7
- Point B:** 1 2 / 3 4 / 5 6 / 7 8
- Point G:** 2 1 / 4 3 / 6 5 / 8 7
- Point H:** 1 2 / 3 4 / 5 6 / 7 8

應以各藥物作用時間進行評估。



奇美醫療財團法人奇美醫院 Chi Mei Medical Center

文件編號	總院-護理-作標-3-01030	文件名稱	給藥作業指導書	頁次	12/13
				版次	04版

給藥追蹤

追蹤內容 (限50個字)

藥物滴注順暢，注射處無紅腫情形給藥後無不良反應，續評估後續給藥狀況。

圖三 藥物追蹤紀錄

暫停

暫停說明/執行記錄

「暫停」未服藥者，將原因書寫於「暫停說明/執行記錄」

圖四 給藥暫停說明/執行記錄

9.相關文件：無

10.附件：

10.1 流程圖：給藥技術流程

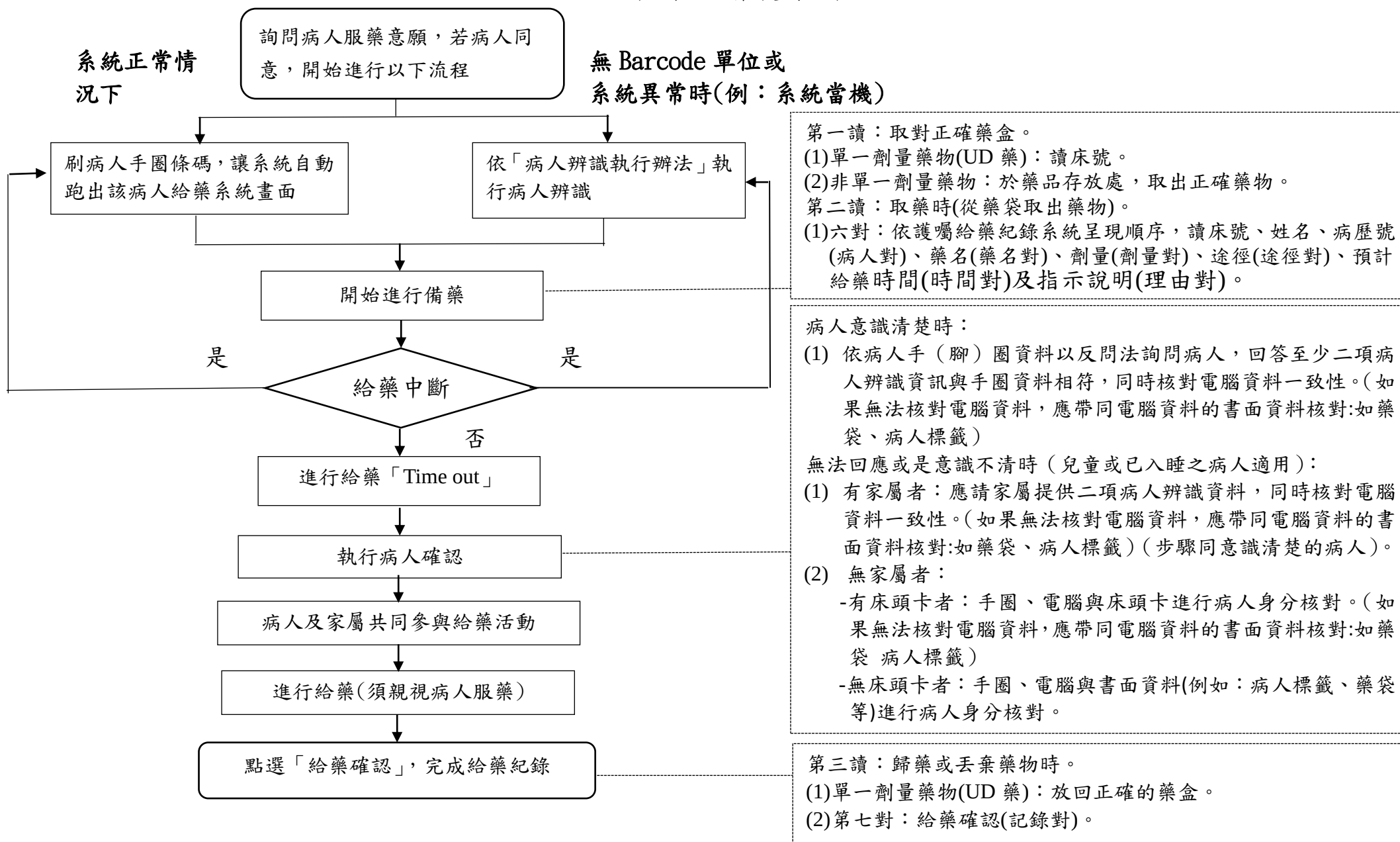


文件 編號	總院-護理-作標 -3-01030	文件 名稱	給藥作業指導書	頁次	13/13
				版次	04 版

- 10.2 口服給藥關鍵項目影片
- 10.3 Ampule 抽藥方式
- 10.4 Vail 抽藥方式
- 10.5 T connect 使用之操作步
- 10.6 筆型胰島素筆型針準備
- 10.7 筆型胰島素注射技術
- 10.8 瓶裝胰島素抽取
- 10.9 空針注射技術
- 10.10 腸促胰激素：(一) 胰妥善一天一次 (二) 易週糖一週一次
- 10.11 昇糖精注射技術

10.1 流程圖：給藥技術流程

流程圖：給藥技術流程



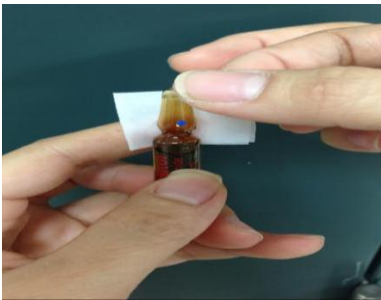
10.2 口服給藥關鍵項目影片



<https://reurl.cc/Gma4Ox>

口服給藥關鍵項目影片

10.3 Ampule 抽藥方式



1.先以手指輕敲 Ampule 上端，使藥物集中於瓶部。

2.將 Ampule 頸部消毒後，以酒精片墊於頸部以剝藥器折斷。

3.自 Ampule 中抽取藥物，勿污染針心。

10.4 Vial 抽藥方式



1.打入所需藥物相等量的空氣於瓶中

2.自瓶中取藥物

10.5 無針式延長線（T connect）使用之操作步驟

1. 定義：

1.1 接觸面：泛指密閉式母針基蓋與無針式延長線（T connect）或 IV set 與無針式延長線（T connect）連接點。

2. 原則：

2.1 執行空針或 IV set 連接免針式接觸面前務必要先使用酒精棉片進行消毒。

2.2 帶至 bedside 的針劑可放置於彎盆內或原空針套內。

3. 無針式延長線（T connect）進行藥物推注步驟：（以推注藥物為例）



1. 將稀釋好的針劑及一個生理食鹽水空針帶至 bedside



2. 以酒精棉片先消毒免針式接觸面



3. 打開無針式延長線上的控制閥，將生理食鹽水置入免針式接觸面



4. 先以空針反抽有無回血，確認 IV 是否於血管內，再進行藥物注射



5. 注射完畢後，移除注射空針



6. 將控制閥關閉，避免回血



7. 結束藥品注射，並以酒精棉片消毒免針式接觸面



8. 最後完成圖

10.6 筆型胰島素筆型針準備



1.酒精消毒



2.撕開針頭保護片



3.裝上針頭並鎖緊



4.轉動劑量設定鈕到刻度 2



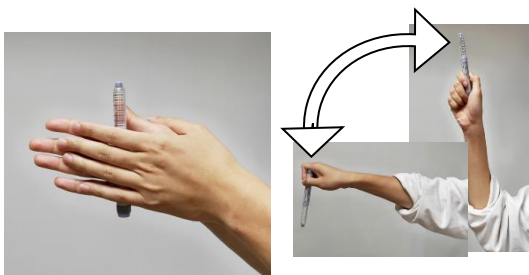
5.將注射鈕壓到底排出注射液(第一次使用要排氣)



6.轉動劑量設定鈕到注射的刻度



7.注射鈕壓到底值到歸零，請停留 15 秒後再拔出針頭



備註：預混型胰島素需在接針頭前做混淆，手掌心滾動 10 次，上下擺動 10 次

10.7 筆型胰島素注射技術

1

選擇位置(以腹部為例)：病人一手握拳蓋住肚臍，另一手掌置於拳頭旁，注射在手掌寬的距離內。



2

酒精棉採環狀由內往外消毒注射部位，待酒精乾才可注射。



3

一手先以兩手指捏起注射部位，另一手持筆型針筒將針頭朝下與皮膚成90度插入。



4

繼續維持捏起的部位，持筆型針筒的手以大拇指按下按鈕，等藥物全部注入後，再停留10-15秒，才將針頭拔出，另一手放開注射部位，再以酒精棉按壓注射部位。



★使用不同長度針頭注射：是否需捏起皮膚及注射角度因人而異。

請將注射過的胰島素針頭放置於空罐子（如保特瓶）並將瓶蓋拴緊，帶回醫院銷毀

※備註：肥胖之病人施打腹部時可不用捏起

10.8 瓶裝胰島素抽取技術

1. 用肥皂將雙手徹底洗乾淨後擦乾。		2. 以75%酒精棉消毒瓶口。	
3. 拿掉針筒下方白色柄蓋。		4. 將橙色針蓋拔開。	
5. 將針筒內的白色拉柄往下拉，抽取所需劑量相等的空氣（抽空氣）。		6. 將針筒垂直插入藥瓶，注入空氣。	
7. 藥瓶倒過來拿好，將針筒內的白色拉柄往下輕拉，抽取所需的劑量。		8. 檢查針筒內是否有氣泡，若有可用手指輕彈針筒，或將已抽出的胰島素全部打回藥瓶，重抽一次。	
9. 再次檢查劑量無誤時，請先將針蓋蓋好針頭，將針筒平放，準備注射。		※若是抽取混濁型胰島素，先將藥品平放掌中，雙手來回輕搓至少20次使藥劑均勻混合後，再接續進行第2個步驟。	

10.9 空針注射技術

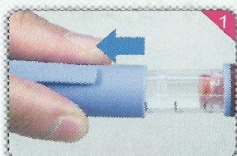
1. 病人一手握拳蓋住肚臍，另一手掌置於拳頭旁，注射在手掌寬的距離內。		2. 酒精棉採環狀由內往外消毒注射部位，待酒精乾才可注射。	
3. 一手先以兩手指捏起注射部位，另一手持針筒將針頭朝下與皮膚成90度插入。		4. 繼續維持捏起的部位，持針筒的手按下推桿，慢慢將藥物全部注入。	
5. 等待至5~10秒，拔出針頭，另一手放開注射部位，再以酒精棉按壓注射部位。			

10.10 腸促胰激素：
(一) 胰妥善一天一次

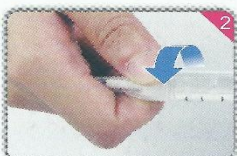
胰妥善注射筆操作說明

準備

在使用注射筆時，請
您利用肥皂將手洗淨



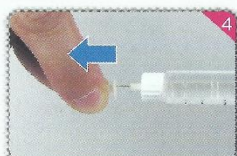
▲ 拉開筆蓋。



▲ 取下針頭的保護片，
將針頭筆直且緊密地
旋入注射筆。



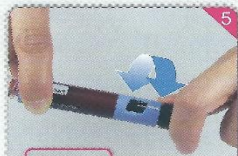
▲ 取下針頭外蓋，
並保留下來。



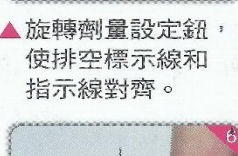
▲ 取下針頭內蓋，
並丟棄。

排空

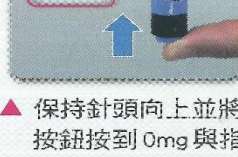
使用新的注射筆之前
請務必檢查排空



▲ 旋轉劑量設定鈕，
使排空標示線和
指示線對齊。



▲ 將針頭向上，握住
注射筆。以手指輕
彈筆管數次，使氣
泡聚集於筆管上端。



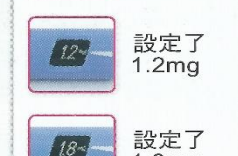
▲ 保持針頭向上並將
按鈕按到 0mg 與指
示線對齊。重複步
驟5到7直到針頭尖
端出現液滴。

設定劑量

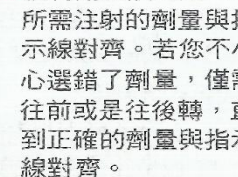
設定劑量前，務必確
定指示線和 0mg 對齊



▲ 設定了
0.6mg



▲ 設定了
1.2mg

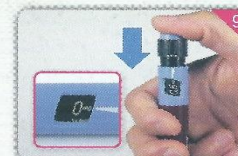


▲ 設定了
1.8mg

△ 請勿嘗試去選擇 0.6mg、1.2mg 或
1.8mg 以外的劑量。務必讓劑量指
示窗的數字與指示線對齊，以確保
您獲得正確的劑量。

注射

依照醫護人員指示的注射
方法將針頭插入皮膚內



▲ 壓住按鈕直到0mg與
指示線對齊。持續將
按鈕壓到底，並且讓
針頭持續停留於皮下
至少 6 至 10 秒鐘。如
此可確保注入您所需
的完整劑量。



▲ 拉出針頭。
您可能會看到有液
滴在針頭尖端。這
是正常的，並不會
對您剛注射的劑量
有影響。

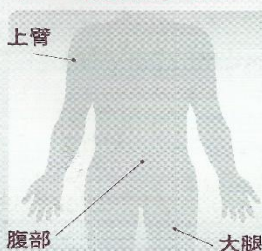


▲ 小心地將針頭外蓋
完全蓋回。然後將
針頭旋取下來。丟
棄針頭並將筆蓋蓋
上。

△ 每次注射後務必取下針頭，
並且將未裝針頭的注射筆妥
善儲存於2℃~30℃的環境。

△ 如有任何問題請洽糖尿病衛教室

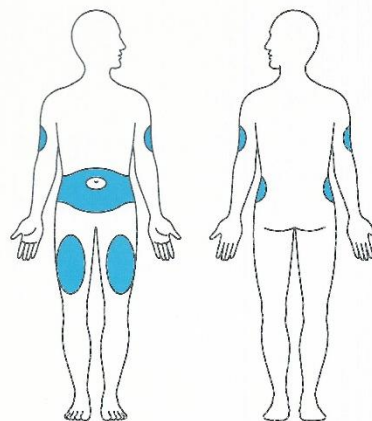
注射部位



(二) 易週糖一週一次

：如何使用Trulicity®(易週糖®)

- 注射筆請存放在冰箱。
- 如果無法冷藏，注射筆在室溫下(<30°C)可放置14天。
- 注射筆包含玻璃的部分，如果掉落，請換一支新的注射筆。
- 藥物可以注射在腹部或大腿，或由別人協助注射在您上臂後側。
- 可以每週注射在身體相同部位，但不要剛好注射在同一個點上。
- 醫護專業人員會協助您選擇最適合的注射部位。

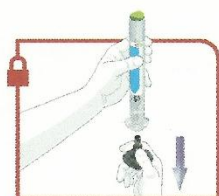


注射部位

如果錯過一劑該怎麼辦？

- 如果距離下次用藥時間還有3天(72小時)以上，請立即注射。
- 如果距離下次用藥時間不到3天，請跳過這一劑。
- 兩劑Trulicity®(易週糖®)之間至少要隔3整天以上。

：使用Trulicity®(易週糖®)簡單方便

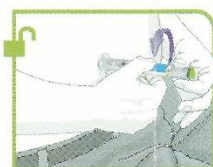


1. 打開蓋子

請確認注射筆已上鎖。

- 拉開灰色蓋子，把蓋子丟掉。

灰色蓋子不可以蓋回注射筆，以免損壞針頭。不要碰觸針頭。



2. 放置並解鎖

將透明底座平貼緊壓乾淨皮膚。

然後，轉動鎖定環解鎖。

注射筆一定要緊壓皮膚，再解鎖。如果太早按下注射按鈕，可能浪費掉一劑藥物。



3. 按住不放

- 按住綠色按鈕不放；會聽到清楚卡嗒聲。

▲繼續將注射筆緊壓皮膚，直到聽到第二聲卡嗒聲。

可能需要5到10秒鐘。

將注射筆拿開。



看到標籤下方，注射筆內的灰色部分時，就表示藥物已經注射完畢。

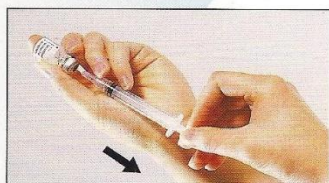


易週糖®注射筆操作影片。如果有疑問，請詢問醫護專業人員。

適用於已處方Trulicity®(易週糖®)控制第二型糖尿病的患者

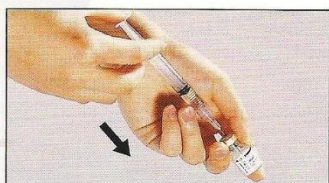
GlucaGen® 昇糖精

操作方法：



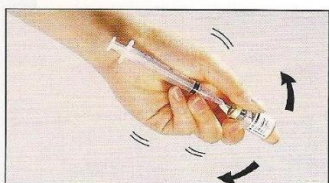
步驟1

撥開白色及橘色塑膠瓶蓋。
用注射針筒抽出全部注射用水。



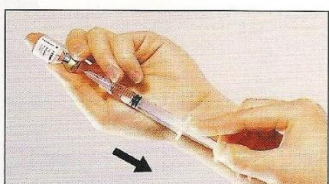
步驟2

再將全部注射用水注入
GlucaGen® 昇糖精粉末瓶內。



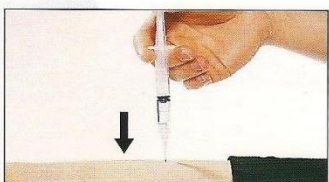
步驟3

不要抽出注射器，先輕輕搖動瓶子，
讓GlucaGen® 昇糖精粉末完全溶解至
澄清。



步驟4

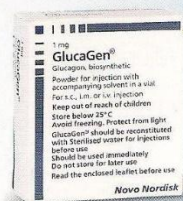
小心回抽所有溶液。然後排出注射器
內的空氣，即可注射。



步驟5

經由肌肉注射、皮下注射、靜脈注射
都可以。

體重輕於25公斤者，請注射一半劑量；
體重超過25公斤者，請注射全部劑量。



****在注射後，當患者回復意識時，
立即給予患者果汁或富含糖份的飲料，
來維持他的血糖濃度回升。**